

Progresión Del TCL al TCM



Sesiones de clínica
Camilo Achury

DIFERENCIAS ENTRE TCL Y TCM - DSMV

CRITERIO	TCL	TCM
Declive	MODERADO	SIGNIFICATIVO
AVD	El déficit cognitivo NO interfiere en capacidad de independencia para actividades básicas e instrumentales.	Los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo en actividades cotidianas.
Delirium	Déficits cognitivos no ocurren en contexto de un delirium	
Otros trastornos	Los déficits cognoscitivos no se explican mejor por otro trastorno mental (trastorno depresivo mayor, esquizofrenia)	

Tipo de DC		Área afectada	Evolución
DC amnésico	Unifunción	Memoria	Enfermedad de Alzheimer
	Multifunción	Memoria y otro área cognitiva	Enfermedad de Alzheimer
DC no amnésico	Unifunción	Área cognitiva distinta de la memoria	Demencia frontal, demencia por C. Lewy, demencia vascular, Enfermedad de Alzheimer
	Multifunción	Dos áreas cognitivas, al menos, distintas de la memoria	Enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, envejecimiento normal

Progresión hacia la demencia en subtipos clínicos de DCL

Table 3. Diagnostic status of the subjects of the MCI groups at the point of the follow-up examination

MCI groups	New diagnosis			
	NCI	MCI	dementia	total
Amnestic MCI	8	16	8	32
Multiple-domain MCI	7	12	22	41
Single non-memory MCI	0	5	3	8
All patients	15	33	33	81

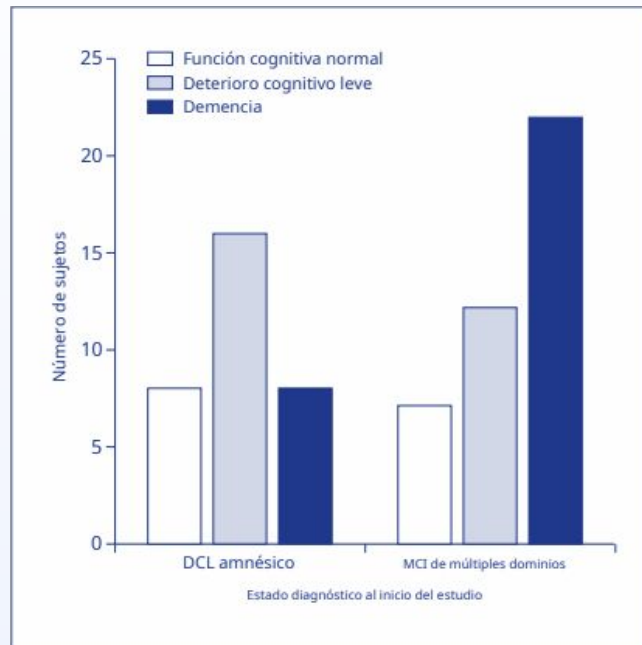


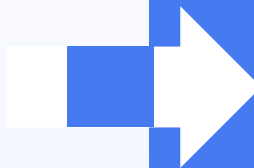
Figura 1. Estado diagnóstico en el momento del examen de seguimiento de los sujetos con deterioro cognitivo leve amnésico y de dominio múltiple al inicio del estudio.

(Alexopoulos, et al.
2006)

CONVERSIÓN DEL DCL A LA DEMENCIA

DCL como fase **prodrómica** de la demencia

**NO todos los pacientes
con DCL
Progresan a Demencia**



Tasas de conversión

6-44,8%

El 33% de pacientes
con DCL se
mantienen o mejoran

ESTUDIO LONGITUDINAL

Evolución de pacientes sin alteración cognitiva								
1999	2004				2007			
	Viven		Fallecieron		Viven		Fallecieron	
	n	%	n	%	n	%	n	%
181 S/A	8	(4.5) DC	-	-	15	(8) DC	3	(2)
	17 Dem	(9)	1	(1)	21 Dem	(12)	1	(1)
	147	81 S/A	-	-	102	(56) S/A	5	(3)
	8	(4.5) Pérdidas			34	(18) Pérdidas		

- Porcentaje de conversión 25,6%
- Tanto en hombres como en mujeres, más de la mitad desarrollaron demencia antes de los 5 años
- El tipo de demencia más frecuente fue la DV (33.3%) y en segundo lugar la EA (15%)

ESTUDIO LONGITUDINAL

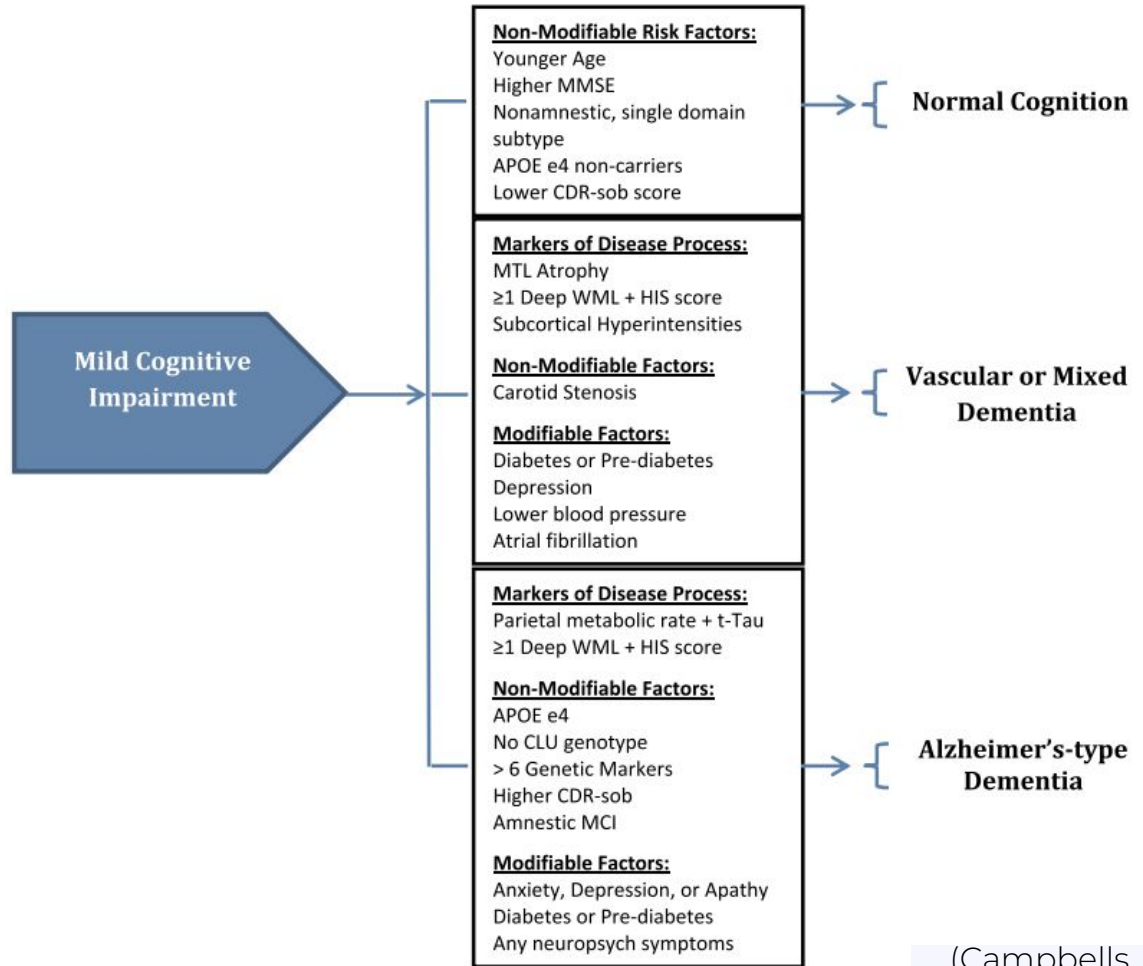
Evolución de pacientes con DCL								
1999	2004				2007			
	Viven		Fallecieron		Viven		Fallecieron	
	n	%	n	%	n	%	n	%
39 DCL	19 DCL	(49)	-	-	17 DC	(44)	2	(5)
	20 Dem	(51)	-	-	11 Dem	(28)	9	(23)

- Se incluyeron a pacientes que acudieron al INNN con una edad ≥ 50 años durante 1999-2000.
- Se tuvieron en cuenta los criterios de Petersen et al., para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve (DCL)
- Se aplicaron pruebas neuropsicológicas (CERAD), considerando los criterios del (DSMIV)

Velásquez, et al. 2019)

Factores de riesgo

- Los factores de riesgo pueden variar según la población



(Campbells, et al.
2013)

Queja subjetiva de informantes como predictor de DCL y Demencia

(Perez, et al 2022)

Metaanálisis

Tanto la queja subjetiva auto informada como la informada por familiares se asocian con un riesgo elevado de transición a DCL y/o demencia

La asociación parece más fuerte y sólida para los datos informados por los informantes [1,38, con un IC del 95 % de 1,16 –1,64, $p < 0,001$] que para datos autoinformados [1,27 (IC del 95%: 1,06 – 1,534, $p = 0,011$)

En CONCLUSION la información corroborada de un informante podría proporcionar detalles importantes para distinguir entre el envejecimiento normal y los estados clínicos.



PERFILES

NEUROPSICOLÓGICOS

Tabla 6. Síntesis de las principales áreas afectadas según cada perfil.

(Miranda, et al, 2015)

		ÁREAS AFECTADAS								
		Atención/ Inhibición	Denominación (Lenguaje)	Fluidez verbal fonológica/ semántica	Habilidades visuo-espaciales	Funciones Ejecutivas	Velocidad de Procesa- miento	Memoria		
								Inmediata (visual/verbal)	De Trabajo	Recuerdo demorado
Enfermedad de Alzheimer			x		x (en estadios avanzados)	x		x (Verbal)		
Enfermedad de Parkinson		x			x	x	x	En discusión		
DCL amnésico (afectación de memoria)								x (con desorientación)		
DCL multidominio amnésico			x		x	x		x (sin diferencia respecto a DCL-a)		
DCL No- Amnésico		x (con diferencias entre estudios)	x		x	Abstracción (sin fuerte evidencia)				
TDM		x (no clara)							x	x
Envejecimiento Normal	Cente- narios	x (En atención selectiva y concentración)	x (menores en relación a EA)	x		x (Desinhibición). Planificación conservada		x		
	Adul-tos Jóve-nes			x (mejor desempeño)		x (con menor impulsividad)				

DCL vascular

Los estudios neuropsicológicos han identificado déficits **atencionales-ejecutivos y desaceleración psicomotora**, con lenguaje y memoria relativamente conservad.

Muy variable

- Multiplicidad de etiologías de la enfermedad vascular.
- Factores como: Momento y ubicación anatómica del ACV, y también de la lateralidad, la gravedad y la extensión de la lesión.

(Stephan, et. Al.
2009)

DCL VS DCLv

Deterioro cognitivo más extenso

principalmente en VP, la atención y la FE

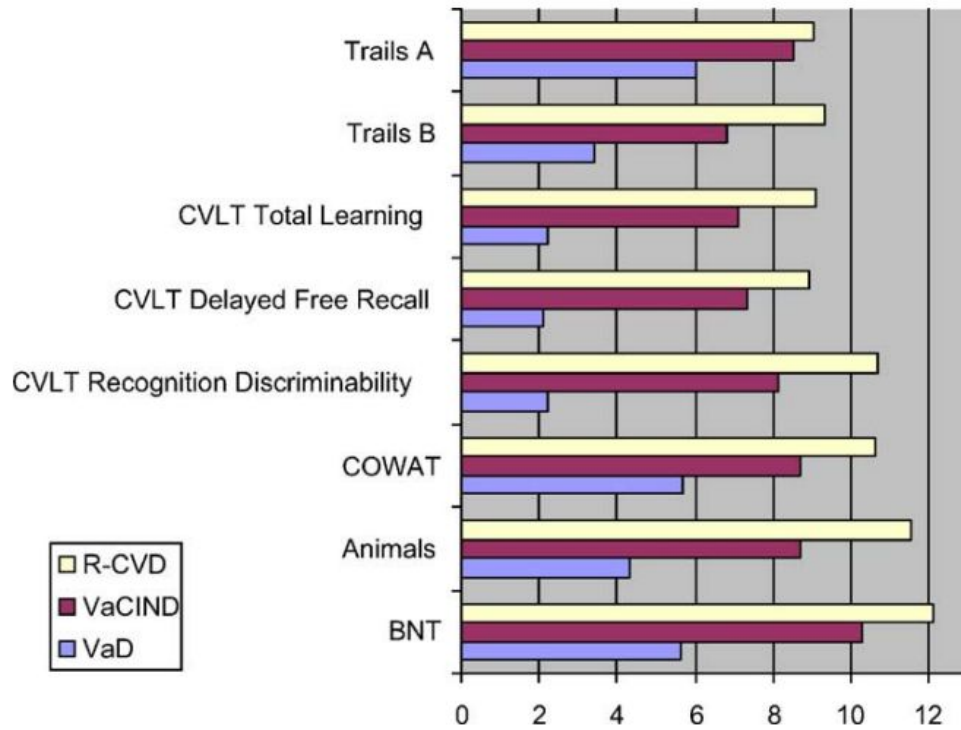
Lesión vascular (por ejemplo, lesiones de la sustancia blanca) se ha asociado con un menor riesgo de progresión de la patología cognitiva y un perfil más estable.

DCLv y DV

Neuropsychological measures	EC ^a	CIND ^b		Significant contrasts
Trails B, <i>M</i> (S.D.)	90.8 (33.5)	190.5 (76.3)		CIND > EC ****
CVLT total learning, <i>M</i> (S.D.)	50.1 (9.6)	34.4 (11.1)		EC > CIND ****
CVLT recognition discriminability, <i>M</i> (S.D.)	0.93 (.08)	0.83 (.11)		EC > CIND ***
Boston Naming Test, <i>M</i> (S.D.)	52.7 (4.5)	50.6 (7.1)		None
COWAT, <i>M</i> (S.D.)	29.4 (8.4)	31.8 (9.6)		None
Category fluency, <i>M</i> (S.D.)	17.8 (6.2)	14.3 (4.1)		None
	R-CVD ^c	CIND ^b	VaD ^d	
Trials A, <i>M</i> (S.D.)	43.2 (15.6)	54.3 (17.7)	94.7 (60.7)	R-CVD < CIND* R-CVD < VaD*** CIND < VaD**
Trails B, <i>M</i> (S.D.)	114.4 (67.8)	190.5 (76.3)	264.5 (63.4)	R-CVD < CIND** R-CVD < VaD*** CIND < VaD**
CVLT total learning, <i>M</i> (S.D.)	41.4 (67.8)	34.4 (11.1)	17.7 (7.0)	R-CVD > VaD**
CVLT recognition discriminability, <i>M</i> (S.D.)	0.93 (.06)	0.83 (.11)	0.69 (.15)	R-CVD > CIND* R-CVD > VaD** CIND > VaD*
Boston Naming Test, <i>M</i> (S.D.)	56.1 (3.4)	50.6 (7.1)	37.1 (10.1)	R-CVD > VaD*
COWAT, <i>M</i> (S.D.)	40.7 (15.2)	31.8 (9.6)	18.5 (11.2)	R-CVD > VaD**
Category fluency, <i>M</i> (S.D.)	20.0 (5.5)	14.3 (4.1)	8.2 (4.1)	R-CVD > CIND** R-CVD > VaD*** CIND > VaD**

(Garretta, et al.
2003)

Demencia vascular

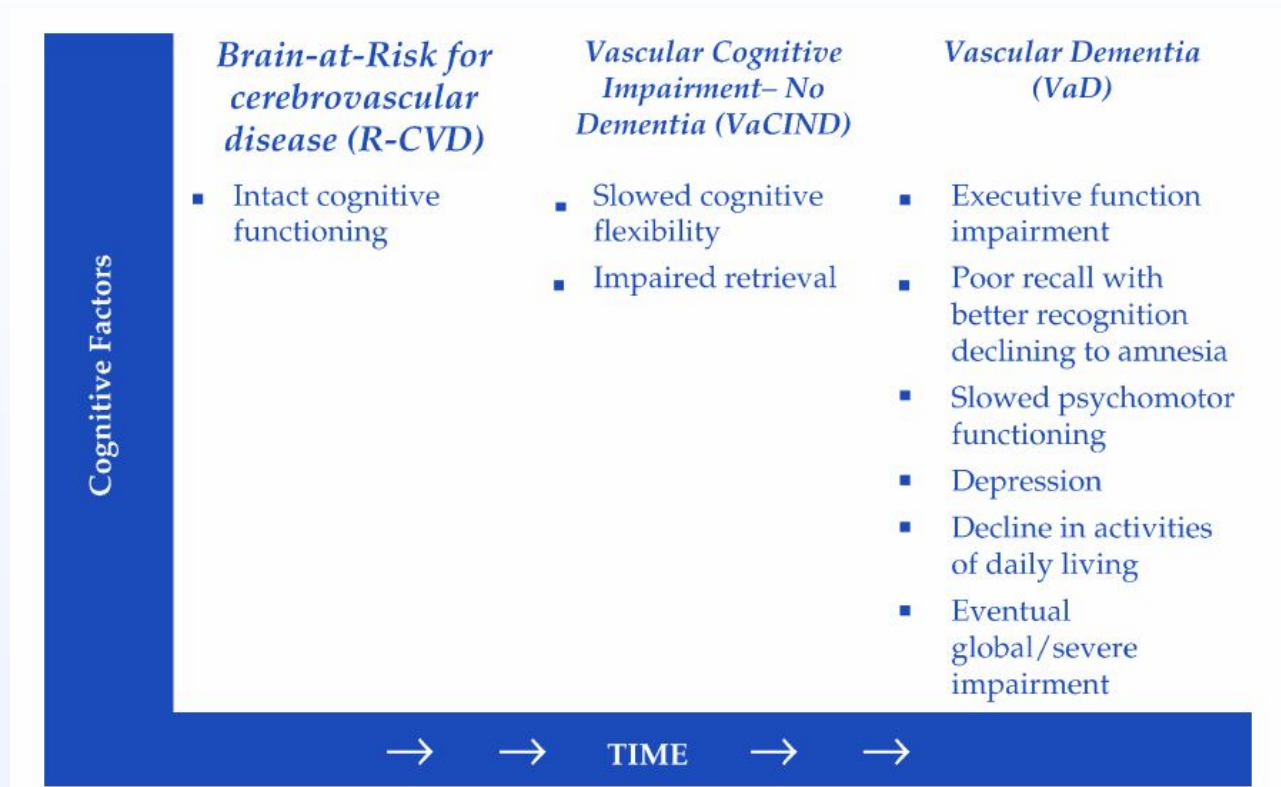


El grupo R-CVD exhibió desempeños cognitivos intactos en comparación, mientras que los individuos con Dv presentaron deterioro en todas las pruebas cognitivas.

DCLv presenta problemas de flexibilidad cognitiva además de dificultades de memoria (recuperación) y antecedentes de factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular

(Garretta, et al. 2003)

Progresión hipotética



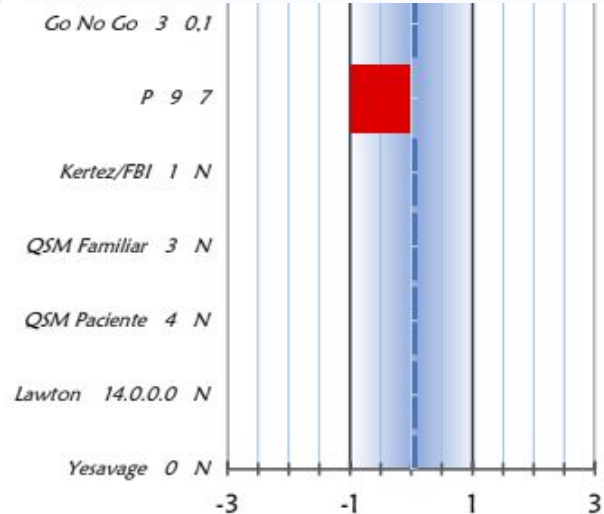
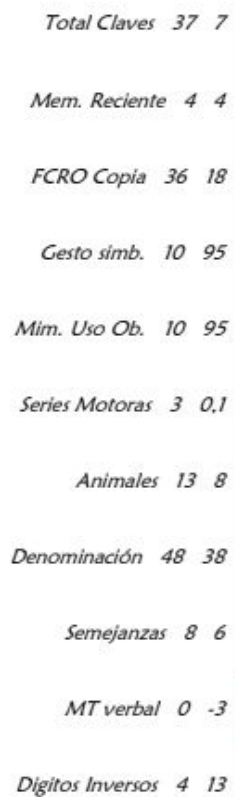
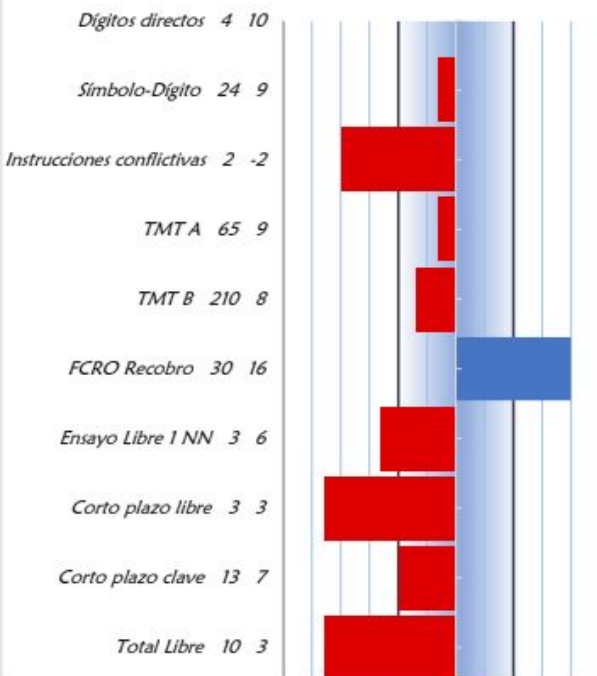
El grupo VaD (tipo progresivo) ha sido descrito en la literatura, con deterioro ejecutivo temprano, funcionamiento psicomotor lento, déficit de memoria basada en la recuperación, disminución de las AVD y características depresivas frecuentes

Caso DCLv

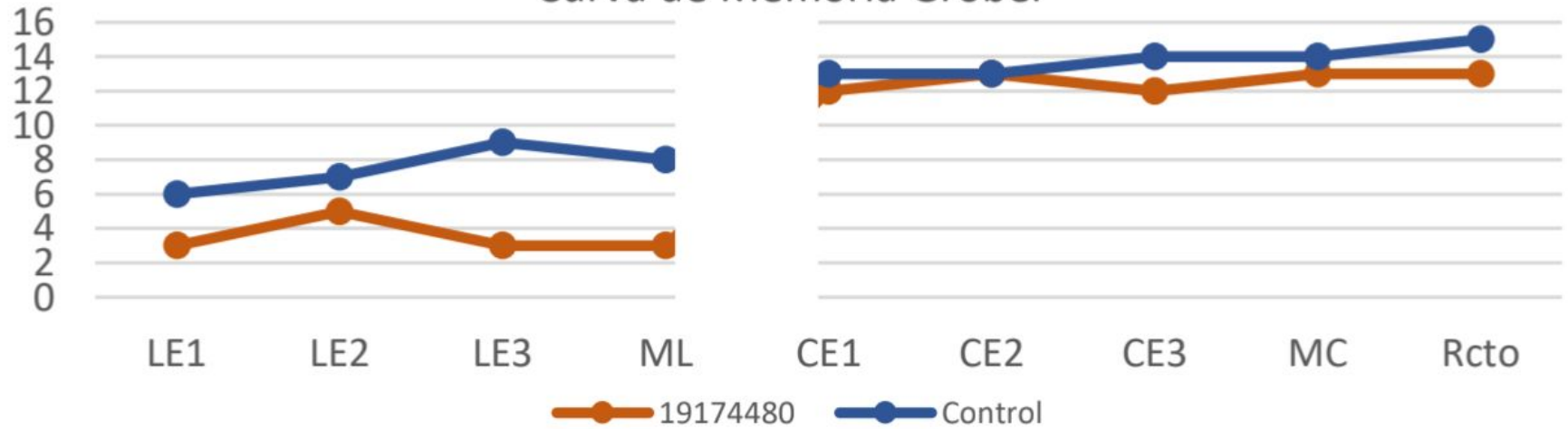
Perfil cognoscitivo evidente en alteraciones leves de predominio subcortical caracterizadas por alteraciones en la **atención selectiva, deterioro en la memoria verbal y memoria de trabajo.**

IDX: trastorno neurocognitivo leve, de tipo amnésico, dominio múltiple; sin alteración del comportamiento. Al tener en cuenta los antecedentes se presume que el cuadro cognitivo está mediado por un componente vascular a confirmar con estudios complementarios

Conserva los procesos de atención sostenida, habilidades visoespaciales y lingüísticas y, las funciones ejecutivas de planeación, abstracción, fluidez.



Curva de Memoria Grober



Caso DCMv

Perfil de funcionamiento cognoscitivo que evidencia un amplio deterioro, con características que se relacionan con cuadro de un probable Trastorno neurocognoscitivo mayor (demencia), que implica elementos subcorticales y corticales, con una gran prevalencia de afectaciones vasculares. En un GDS 5-6 moderado.

Se sugiere terapia cognitiva y valoración audiológica/oftalmológica.

Dígitos directos 4 10

TMT A 43 -17

Ensayo LP 0 -2,4

Ensayo 3 6 -1,6

Ensayo 2 3 -1,6

Ensayo 1 2 -1,6

Mem. Remota 0 4

Mem. Reciente 0 4

Gesto simb. 2 <10

Mim. Uso Ob. 8 <10

Animales 5 4

Semejanzas 0 4,5

MT verbal 0 -3

Dígitos atrás 0 -3

Dígitos Inversos 0 8

Haylin Test 0 -3

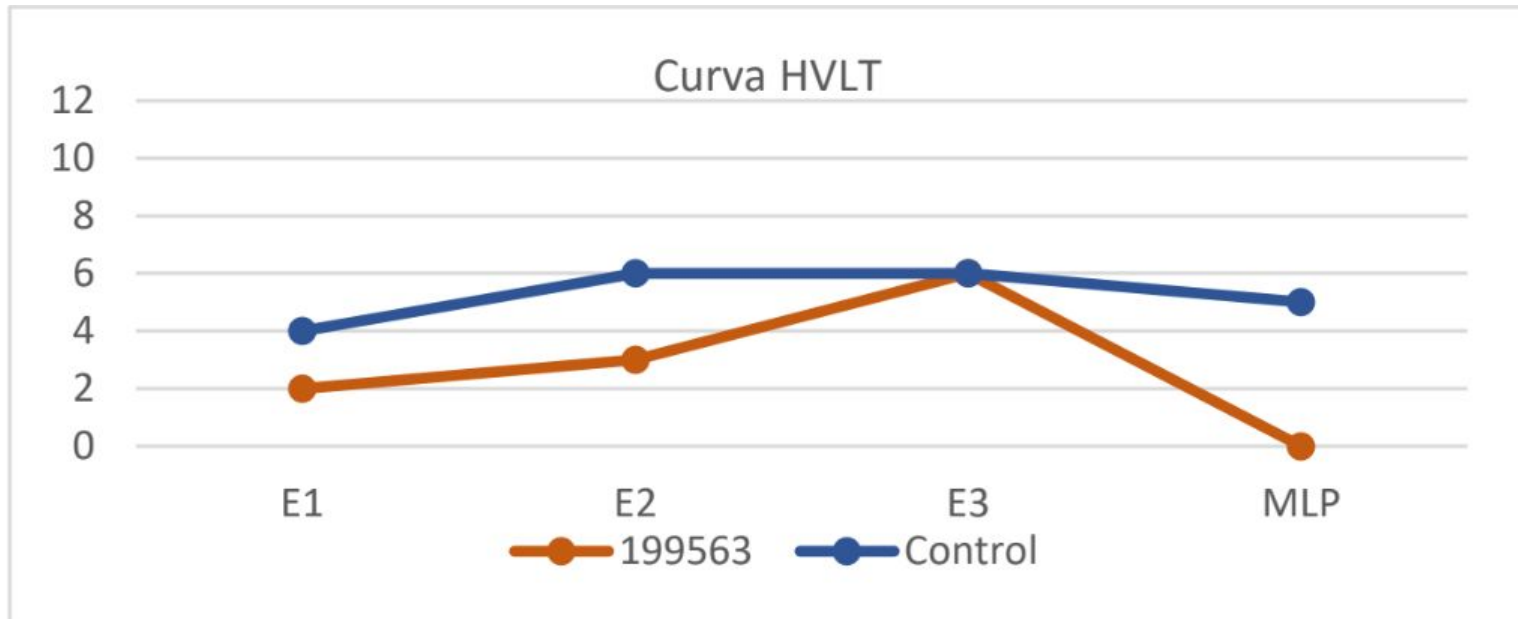
Refranes 0 -3

P 1 4

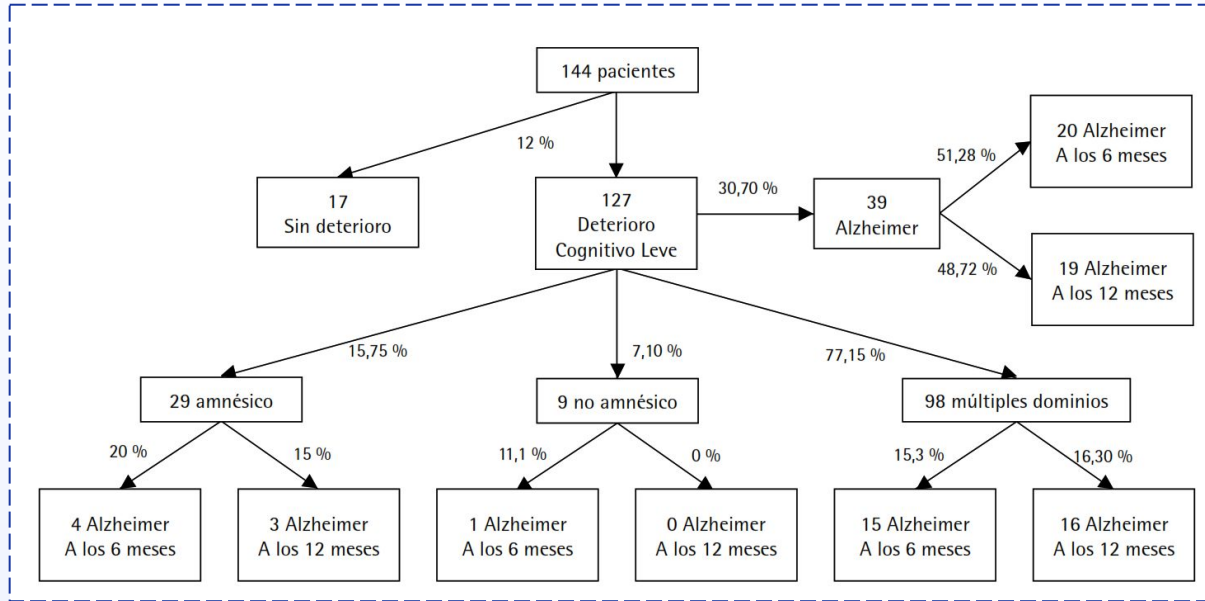
Kertez/FBI 44 P

QSM Familiar 30 P

Lawton 0.2.1.11 A



DCL y Demencia en EA



□ Riesgo de demencia EA
Según subtipos.

□ El grupo de DCLmd fue el más frecuente, sin embargo fue mayor la conversión a demencia en el DCLa

Perfil DCL-EA

Table 3

Neuropsychological data of MCI-AD, MCI-DLB and MCI-stable patients.

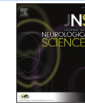
Parameters	MCI-AD	MCI-DLB	MCI-stable	p-Value
Attention				
Digit span, forward	5.1 (1.2)	4.5 (1.1)	5.6 (1.2)	NS
Digit span, backward	2.6 (0.9)	2.5 (0.7)	3.1 (0.8)	NS
Language and related function				
K-BNT	36.7 (4.8)	37.7 (5.5)	42.0 (9.3)	<0.05 ^{b,c}
Repetition	13.2 (0.5)	13.5 (1.1)	14.3 (0.9)	NS
Calculation	9.6 (1.6)	9.5 (1.6)	10.4 (1.7)	NS
Visuospatial function				
RCFT	30.2 (2.3)	27.9 (7.1)	32.7 (3.3)	<0.001 ^{a,b,c}
Verbal memory function (SVLT)				
Free recall	13.9 (2.1)	15.1 (4.4)	17.1 (4.1)	<0.05 ^{b,c}
Delayed recall	2.1 (1.1)	3.8 (2.0)	6.5 (3.5)	<0.001 ^{b,c}
Recognition	16.7 (1.8)	18.1 (2.2)	19.2 (2.3)	<0.001 ^{a,b,c}
Visual memory function (RCFT)				
Immediate recall	8.3 (4.1)	10.3 (5.2)	13.2 (5.4)	<0.001 ^{b,c}
Delayed recall	8.1 (5.2)	9.2 (4.9)	11.3 (4.8)	<0.05 ^{b,c}
Recognition	16.6 (2.1)	16.1 (1.8)	18.5 (1.4)	<0.001 ^{b,c}
Frontal executive function				
Phonemic generative naming	13.5 (6.0)	12.7 (8.1)	17.2 (9.1)	0.04 ^{b,c}
COWAT, animal	11.3 (2.2)	10.5 (3.0)	13.1 (4.1)	0.03 ^{b,c}
COWAT, supermarket	12.3 (3.1)	11.2 (2.6)	14.8 (4.4)	0.04 ^{b,c}
Stroop word test	99.6 (9.3)	97.1 (24.7)	105.2 (14.7)	0.05 ^{b,c}
Stroop color test	72.5 (14.7)	58.2 (26.0)	79.4 (16.3)	<0.001 ^{a,b,c}



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the Neurological Sciences

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jns



Olfactory function and neuropsychological profile to differentiate dementia with Lewy bodies from Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment: A 5-year follow-up study

Jung Han Yoon ^{*}, Min Kim, So Young Moon, Seok Woo Yong, Ji Man Hong

Department of Neurology, Ajou University School of Medicine, Suwon, South Korea



- Pacientes con DCL-EA tuvieron puntuaciones significativamente más bajas que los pacientes con DCL estable
- Los pacientes con DCL-EA obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en pruebas de memoria, función frontal-ejecutiva, K-BNT y RCFT que

Perfil Demencia EA leve

(Caccapolo, et al 2003)

Cognitive domain	Questionable dementia	Mild AD
Memory		
SRT Total Recall	-.57 (.13) [71]	-1.3 (.06) [164]
SRT Delay Recall	-.73 (.09) [71]	-1.3 (.05) [163]
SRT Delay Recognition	-.51 (.16) [71]	-1.6 (.15) [163]
Benton Recognition	-.24 (.10) [68]	-.45 (.08) [163]
WMS-R Logical Memory	-.53 (.18) [65]	-1.3 (.07) [159]
WMS-R Log Mem Delay	-.60 (.15) [65]	-1.4 (.07) [158]
WMS-R Vis Reproduction	-.45 (.13) [65]	-.92 (.07) [156]
WMS-R Vis Repro Delay	-.69 (.11) [65]	-1.1 (.04) [156]
Language		
Boston Naming Test	-.28 (.13) [69]	-.56 (.08) [163]
CFL Mean	-.03 (.12) [71]	-.26 (.08) [165]
Category Fluency Mean	-.24 (.05) [70]	-.58 (.04) [165]
Repetition	-.05 (.09) [67]	-.05 (.04) [160]
Attention		
Digit Span Raw	-.31 (.13) [67]	-.39 (.07) [165]
Arithmetic Raw	-.20 (.12) [66]	-.50 (.08) [167]
Shape Omits	-.07 (.09) [68]	-.51 (.09) [162]
Digit Symbol Raw	-.33 (.08) [67]	-.65 (.06) [167]
TMX Omits	-.06 (.16) [68]	-.22 (.09) [161]
Visuospatial functioning		
Block Design Raw	-.54 (.13) [67]	-.88 (.07) [165]
Rosen Drawing Test	-.13 (.08) [69]	-.11 (.07) [162]
Benton Matching	.22 (.07) [69]	-.14 (.07) [163]
Object Assembly Raw	-.33 (.08) [67]	-.65 (.06) [167]
Abstract reasoning		
Similarities Raw	.13 (.10) [67]	-.14 (.06) [165]
Identities/Oddities	.12 (.07) [67]	-.23 (.07) [162]

Memoria y razonamiento abstracto, son los que mejor diferencian entre EA y GC.

También se encontró menor rendimiento en:

- Recobro LP y recobro inmediato de historias.
- Semejanzas, identidades y rarezas
- Fluidez semántica
- Símbolo dígito, Dígitos y Cancelación
- Cubos

(MAYOR DETERIORO COGNITIVO GLOBAL en comparación con GC y otras demencias)

Caso DCL EA (M60)

La evaluación objetiva de sus funciones cognoscitivas identificó una disminución de la memoria anterógrada verbal (capacidad de hacer nuevos aprendizajes), de los procesos atencionales que dependen de la velocidad de procesamiento visual y de algunas funciones ejecutivas (abstracción conceptual, memoria de trabajo, control inhibitorio y planeación).

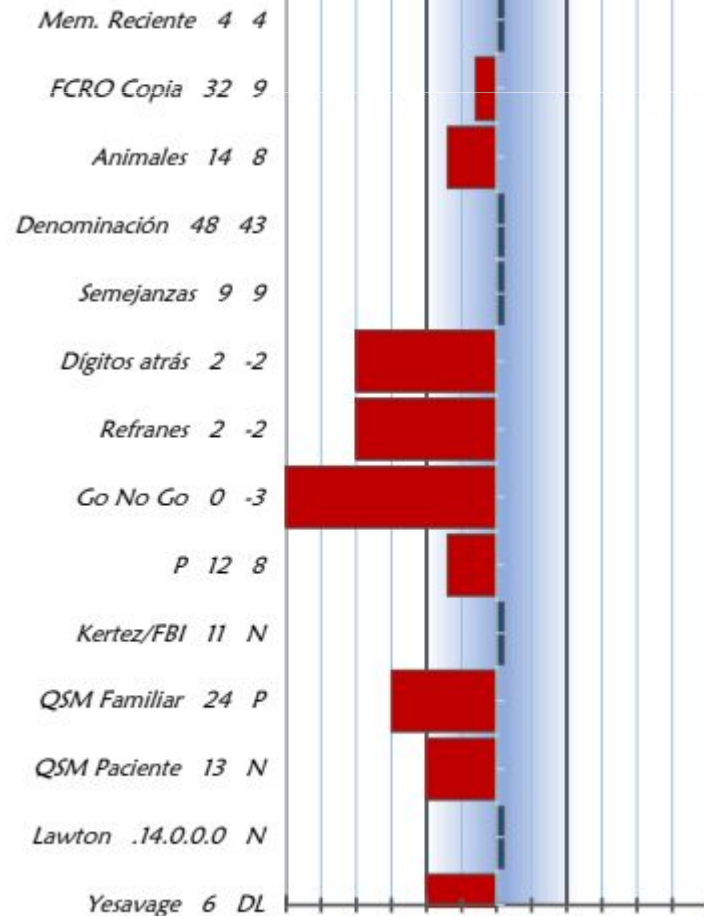
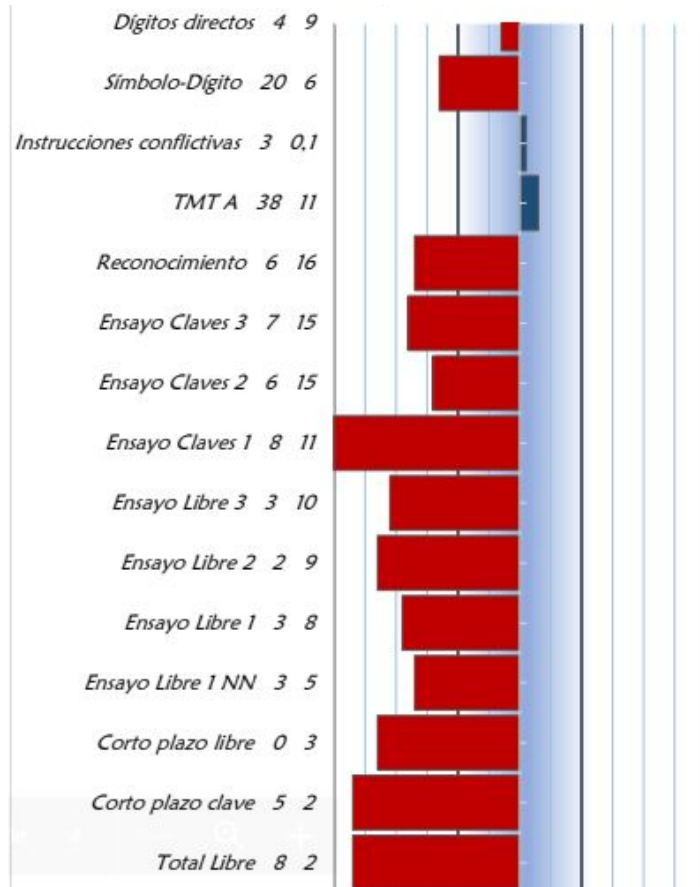
Su perfil cognoscitivo es consistente con la presencia de un trastorno neurocognitivo leve amnésico multidominio con presencia de características de predominio cortical. La edad de inicio de los síntomas, el curso insidioso y progresivo de los mismos, el compromiso primario de la memoria y el predominio de características corticales en su perfil cognoscitivo (dificultad en almacenamiento y presencia de intrusiones), podrían indicar la instauración de un proceso neurodegenerativo primario asociado a la Enfermedad de Alzheimer en una etapa inicial de la enfermedad (GDS 4).

Motivo de consulta

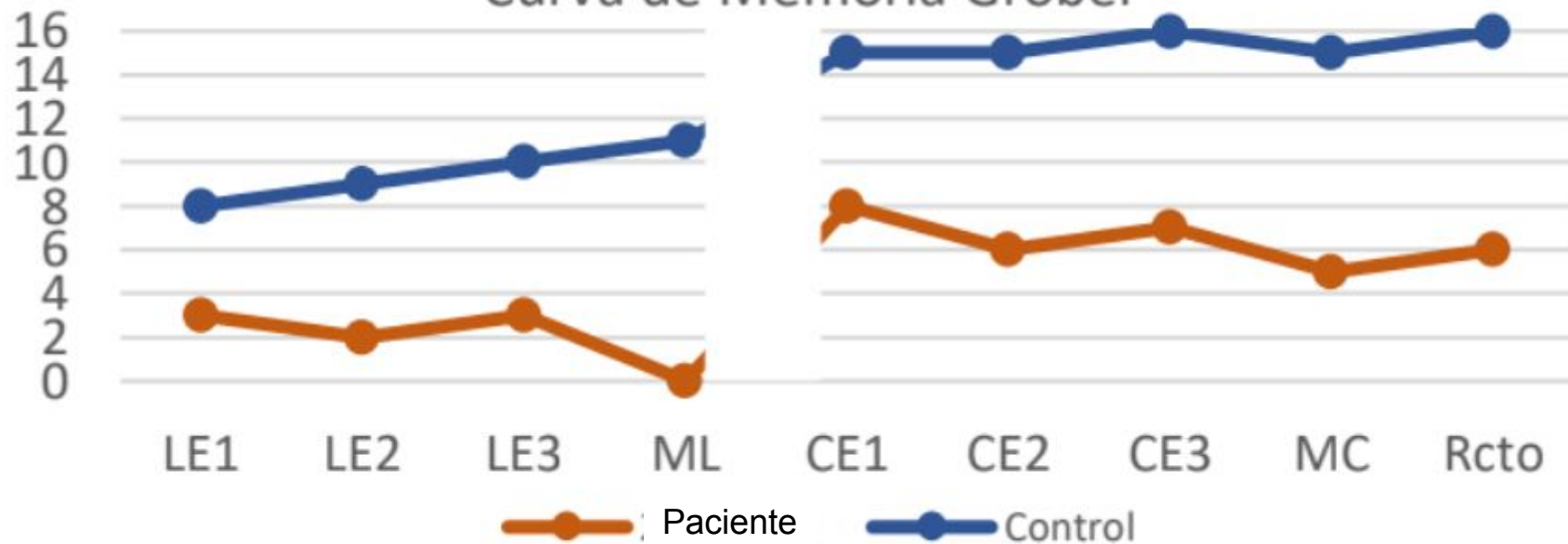
La paciente refiere: "Se me olvidan las cosas". Refiere dificultad en memoria episódica reciente de aproximadamente un año de evolución, inicio insidioso y curso lentamente progresivo. Adicionalmente, refiere síntomas afectivos desde el inicio de la pandemia.

Médicos

Patológicos /Médicos	Alérgicos
HTA. Meningitis neonatal.	(-)
Sensoriales/Motores	Tóxicos
Usa gafas para leer.	(-)
Psiquiátricos	Terapéuticos
(-)	(-)
Farmacológicos	Quirúrgicos
Metoprolol. Losartán Hidroclorotiazida.	Del riñón, apendicectomía, de la mano (túnel del carpo), eventración.
Traumáticos	Familiares
(-)	Pérdida de memoria no especificada en madre. Diabetes en padre.
Paraclínicos	
(-)	



Curva de Memoria Grober



Caso DCM EA (H89)

Paciente de 89 años conocida por el servicio, con antecedente de Deterioro Cognitivo de más de 5 años de evolución de acuerdo al reporte familiar.

Según lo reportado la evaluación anterior (2019) continúa presentado alteraciones en el componente ejecutivo, principalmente en el pensamiento abstracto, flexibilidad cognitiva y control atencional lo cual afecta la velocidad de procesamiento, además tiene dificultades para almacenar y evocar información audio-verbal y visual, dificultades en las praxias visoconstructivas, y en la denominación.

En cuanto a la funcionalidad con base en el reporte familiar, continúa realizando tareas de casa adaptadas a su condición médica sin manifestar deterioro significativo. Se reportan cambios significativos en la esfera conductual con estabilidad del componente anímico.

Considerando las características clínicas del caso se encuentra un Trastorno Neurocognitivo Mayor que continúa en GDS-5, se requiere realizar seguimiento.

Motivo de consulta

La paciente desconoce el motivo de consulta, la familiar comenta "ella tiene Alzheimer desde hace 9 años y la Dra quiere saber cómo ha evolucionado"

Médicos

Patológicos /Médicos	Alérgicos
Diabetes, HTA, coagulo pulmonar, hipotiroidismo, enfermedad coronaria	Ibuprofeno
Sensoriales/Motores	Tóxicos
Dificultades en la marcha, requiere el uso de bastón, utiliza gafas.	(-)
Psiquiátricos	Terapéuticos
Depresión hace 10 años	(-)
Farmacológicos	Quirúrgicos
Furosemida 40 mg, Apixaban 5 mg, Carvedilol 6.25 mg, Enalapril 20 mg, Rivastigmina 27 mg, Calcio 1500 mg, Tiotropio bromuro.	Hernia, varices
Traumáticos	Familiares
(-)	Hermanos y papá, cáncer de estómago, diabetes
Paraclínicos	
Evaluación Neuropsicología 10/2019: Dentro de la evaluación se identifica fallas en funciones ejecutivas (concretismo, desorganización, perseveración, impulsividad) con mayor compromiso en la corteza orbitofrontal praxias, atención, lenguaje (dificultad para la comprensión en instrucciones complejas y sencillas) con mayor compromiso en memoria episódica y semántica. Perfil se relaciona con trastorno neurocognitivo mayor debido a Enfermedad de Alzheimer, estadio moderado (GDS 5).	

Dígitos directos 4 10

TMT A 180 7

Ensayo LP 0 -2,4

Ensayo 3 4 -1,4

Ensayo 2 5 -1,4

Ensayo 1 3 -1,4

FCRO Recobro 0 4

Mem. Reciente 2 4

FCRO Copia 5 5

Color 45 10

Palabras 56 8

Animales 12 10

Denominación 31 34

Semejanzas 2 4,5

Dígitos Inversos 3 12

Refranes 0 -3

Palabras-Color 15 9

P 5 7

Kertez/FBI 27 P

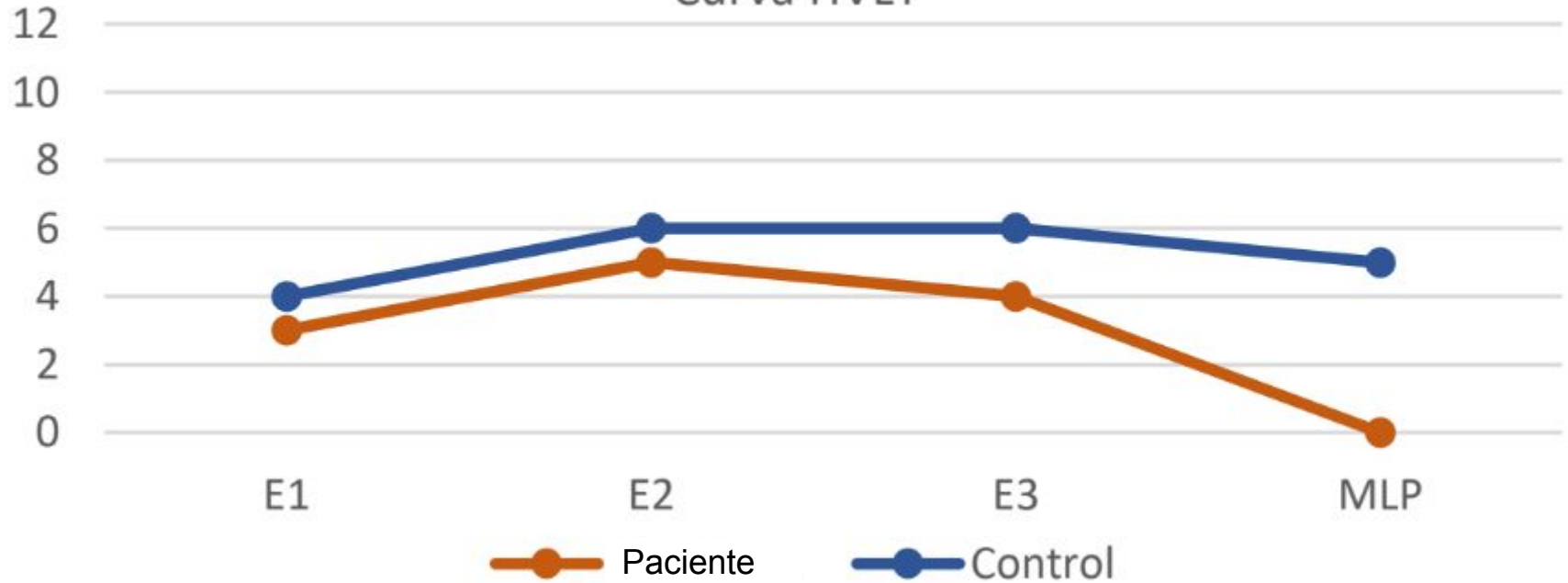
QSM Familiar 32 P

QSM Paciente 12 N

Lawton .0.4.7.3 A

Yesavage 3 N

Curva HVLT



Perfil DCL-EP

El rendimiento cognitivo puede diferir en :

- Estados motores "encendidos" vs "apagados", particularmente en las pruebas de función ejecutiva y también en aquellos pacientes con EP con fluctuaciones motoras.
- Presencia de depresión, ansiedad, apatía, psicosis, fatiga y alteraciones del sueño, comunes en la EP



(Goldman y Litvan, 2011)

Dominios cognitivos
alterados

Función ejecutiva

Velocidad psicomotora

Hab. Visoespaciales

Lenguaje

Memoria

**Predomina DCL no
Amnesico de unico
dominio (FE)**

Perfil Demencia EP

Las mejores para discriminar entre DCL en EP

- Tareas de atención (TMT-B, TMT A, DOT-B)
- Memoria semántica (memoria en prosa, recuerdo inmediato y retardado y similitudes)
- Lenguaje (tarea de fluidez de categoría, prueba de denominación)
- Funciones visoespaciales (CDT)

Las de mayor sensibilidad para Demencia EP fueron:

- Hab. visoespaciales (copia ROCF)
- Hab. visuoperceptivas (VOSP)
- Lenguaje (tarea de fluidez de categorías y nombres)
- FE (tarea de fluidez fonológica)

Significance of individual test-score mean differences between-group (a) and cut-off scores of tests that discriminated across all PD cognitive statuses (b).

a)			
	PD-MCI Vs PD-CNT ^a	PDD Vs PD-MCI ^b	
MMSE		$p < 0.0001$	
MoCA	$p < 0.0001$	$p < 0.0001$	
ROCF copy		$p < 0.0001$	
TMT B	$p < 0.0001$		
TMT B-A	$p < 0.0001$		
Letter fluency		$p < 0.002$	
Category fluency	$p < 0.001$	$p < 0.0001$	
Similarities	$p < 0.0001$		
DOT-B	$p < 0.0001$		
CDT	$p < 0.0001$	$p < 0.002$	
Prose memory test immediate	$p < 0.0001$		
Prose memory test recall	$p < 0.003$		
VOSP		$p < 0.002$	
Naming	$p < 0.001$	$p < 0.0001$	
b)			
	PD-CNT	PD-MCI	PDD
MoCA	>26	≤25	≤20
Category fluency	≥41	<41	≤30
Naming	>26	≤26	≤24
CDT	>13	≤13	≤11

EA vs EP (tipos de error en las pruebas)

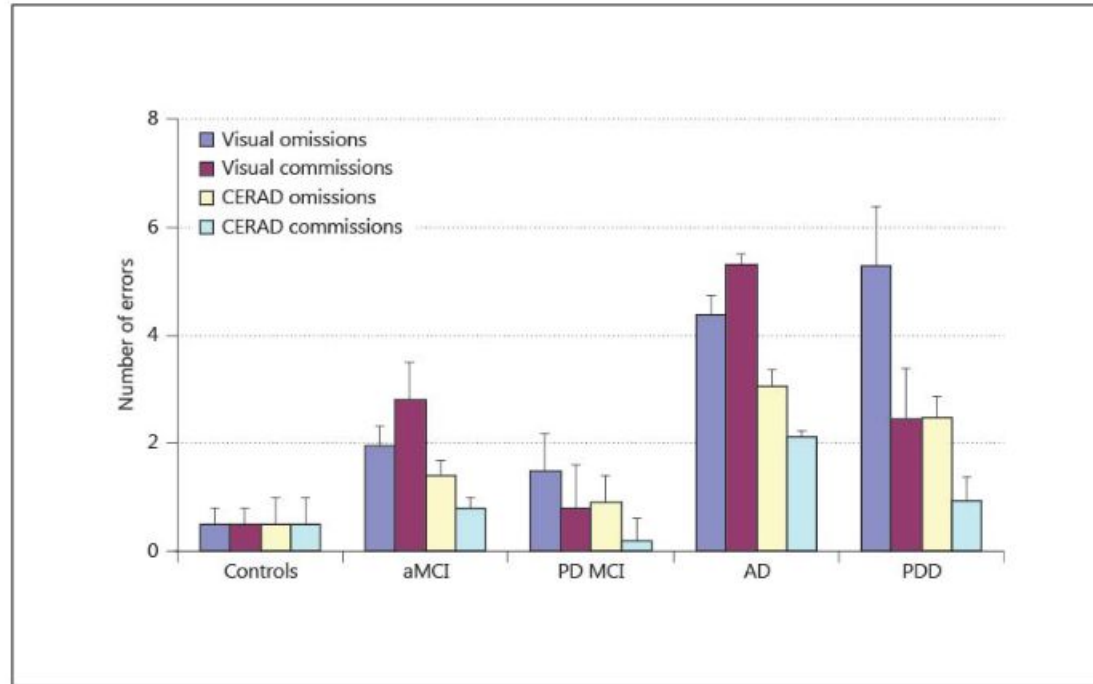


Fig. 1. Only aMCI and AD patients performed more commissions than omissions in the visual recognition task. Moreover, aMCI patients differed from PD MCI patients in CERAD word list commissions, and patients with AD differed from patients with PDD.

(Hildebrandt, et al. 2013)

Caso DCL EP (H83)

Diagnostico Parkinson hace tres años

La evaluación objetiva de sus funciones cognitivas identificó una disminución de algunas de sus funciones ejecutivo-conceptuales. Por otra parte, la orientación; los procesos atencionales; la memoria anterógrada (capacidad de consolidar nuevos aprendizajes); las habilidades viso-construccionales; y las habilidades lingüísticas y semánticas están relativamente conservadas.

En suma, su perfil cognoscitivo es consistente con la presencia de un trastorno **neurocognitivo leve no amnésico de predominio disejecutivo**, en conjunción con una disminución de la funcionalidad para la realización de las actividades instrumentales de la vida diaria (pero que estaría explicada en gran parte por el problema motor).

Motivo de consulta

La familiar refiere: "Hace varios años que empezó a perder la memoria, es paciente de Parkinson hace tres años, pero el año pasado tuvo una crisis muy fuerte asociada a duelo por la muerte de su hermano, en esas semanas no dormía, tenía ansiedad, se perdía en tiempo y espacio. la neuróloga quiere tener exámenes actualizados". Refiere alteraciones en memoria episódica reciente de aproximadamente diez años de evolución, inicio insidiosos y curso lentamente progresivo. Tiene enfermedad de Parkinson desde hace 3 años, actualmente presenta temblor de las manos de predominio izquierdo, inestabilidad en la marcha (camina inclinado hacia adelante y con pequeños pasos), rigidez axial, hipomimia, hipofonía, mareos y leve disartria.

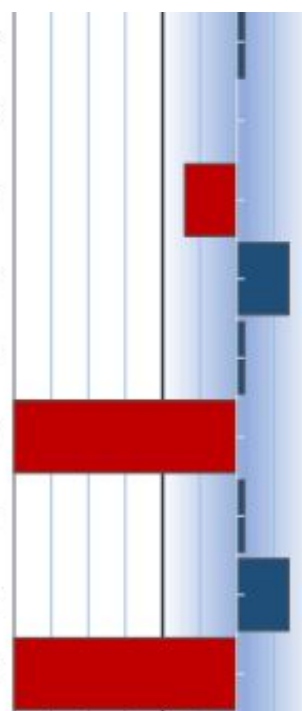
Médicos

Patológicos /Médicos	Alérgicos
Anticoagulado. Enfermedad de Parkinson. Tres IM. HTA. SAHOS.	(-)
Sensoriales/Motores	Tóxicos
Usa gafas permanentes. Hipoacusia de OI. Presenta temblor de las manos de predominio izquierdo, inestabilidad en la marcha (camina inclinado hacia adelante y con pequeños pasos), rigidez axial, hipomimia, hipofonía, mareos	Ex fumador.
Psiquiátricos	Terapéuticos
(-)	Recibe terapias ocupacionales y de fonoaudiología. Recibió fisioterapia el año pasado.
Farmacológicos	Quirúrgicos
Quetiapina. Levodopa-carbidopa. Mirapex. Losartán. Betaloc. Atorvastatina. Coumadin.	P`rostata. Lente intraocular OI. De la mano.
Traumáticos	Familiares
(-)	Enfermedad de Parkinson en hermana. Demencia tipo Alzheimer en hermanos.
Paraclínicos	
RMN cerebral de 2021: "Cambios por atrofia cortico-subcortical. Múltiples focos de hiperseñal T2 en la sustancia blanca subcortical y periventricular hemisférico bilateral por áreas de desmielinización hipóxica-crónica Fase 2. RMN cerebral de 2015: Leucoencefalopatía vascular de distribución periventricular y supraventricular. Trae EvNP de 2017, 2015, 2014 normales. EvNP de 2013 y 2010: Trasnorno neurocognitivo leve de predominio disejecutivo.	

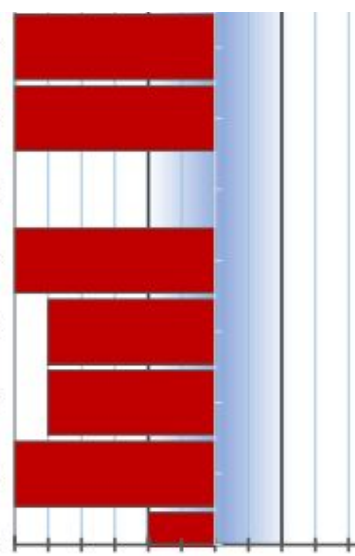
Dígitos directos	4	10
Símbolo-Dígito	9	9
Instrucciones conflictivas	3	0,1
TMT A	111	10
FCRO Recobro	10	12
Ensayo Libre 1 NN	6	12
Corto plazo libre	10	13
Corto plazo clave	15	12
Total Libre	20	11
Total Claves	43	12



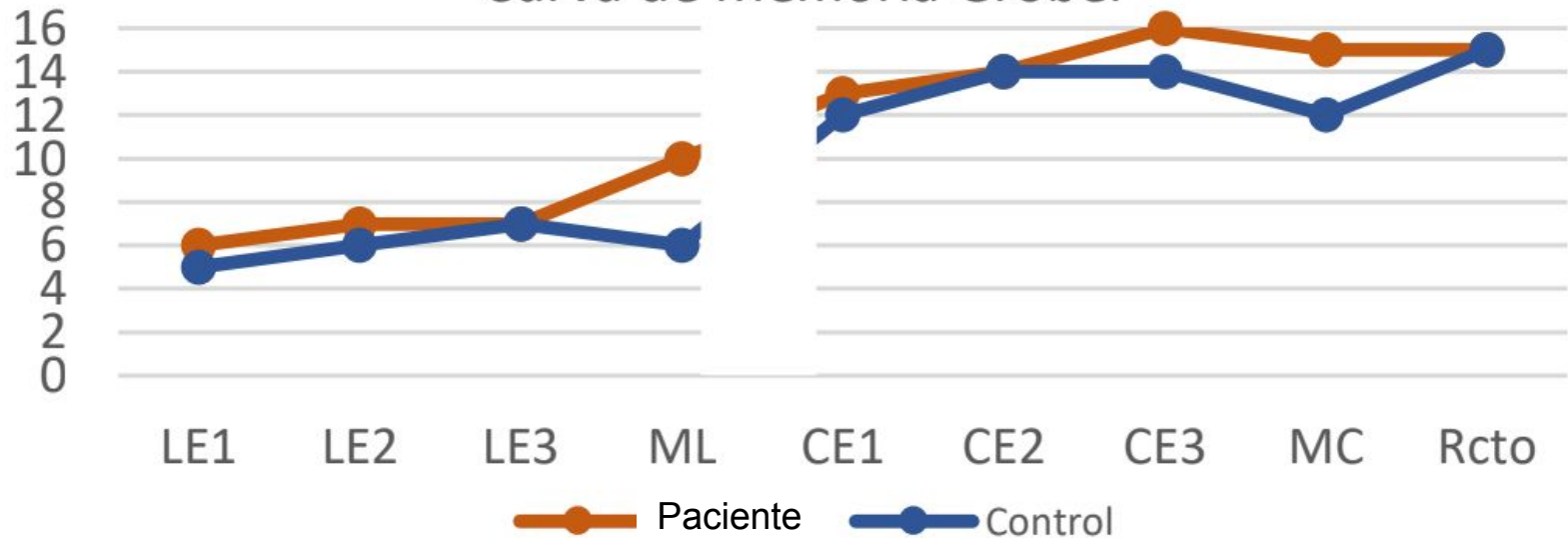
Mem. Reciente	3	3
Margarita	1	0
FCRO Copia	14	8
Animales	17	12
Denominación	42	35
Semejanzas	5	7
MT verbal	2	0,1
Dígitos Inversos	3	12
Haylin Test	0	-3



Refranes	1	-3
Go No Go	0	-3
P	9	10
Kertez/FBI	29	P
QSM Familiar	32	P
QSM Paciente	35	P
Lawton	.2.4.3.5	A
Yesavage	6	DL



Curva de Memoria Grober



Caso DCM EP (H86)

Paciente de 86 años, con antecedente de enfermedad de parkinson desde hace 27 años, presentando queja de memoria desde hace 4 años, afectando la funcionalidad instrumental.

Los resultados muestran un perfil cognitivo con alteraciones generalizadas en relación a dominios evaluados como orientación temporal, habilidades lingüísticas de denominación, escritura en la memoria semántica, de tipo ejecutivo en el pensamiento asociativo, pensamiento abstracto, funcionamiento atencional, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, fluidez verbal y con un compromiso importante en la memoria anterógrada verbal, conservando las praxias ideacionales e ideomotoras.

De esta forma, los resultados en conjunción con su funcionalidad, sugieren **trastorno neurocognitivo mayor relacionado con enfermedad de parkinson en estado moderado**.

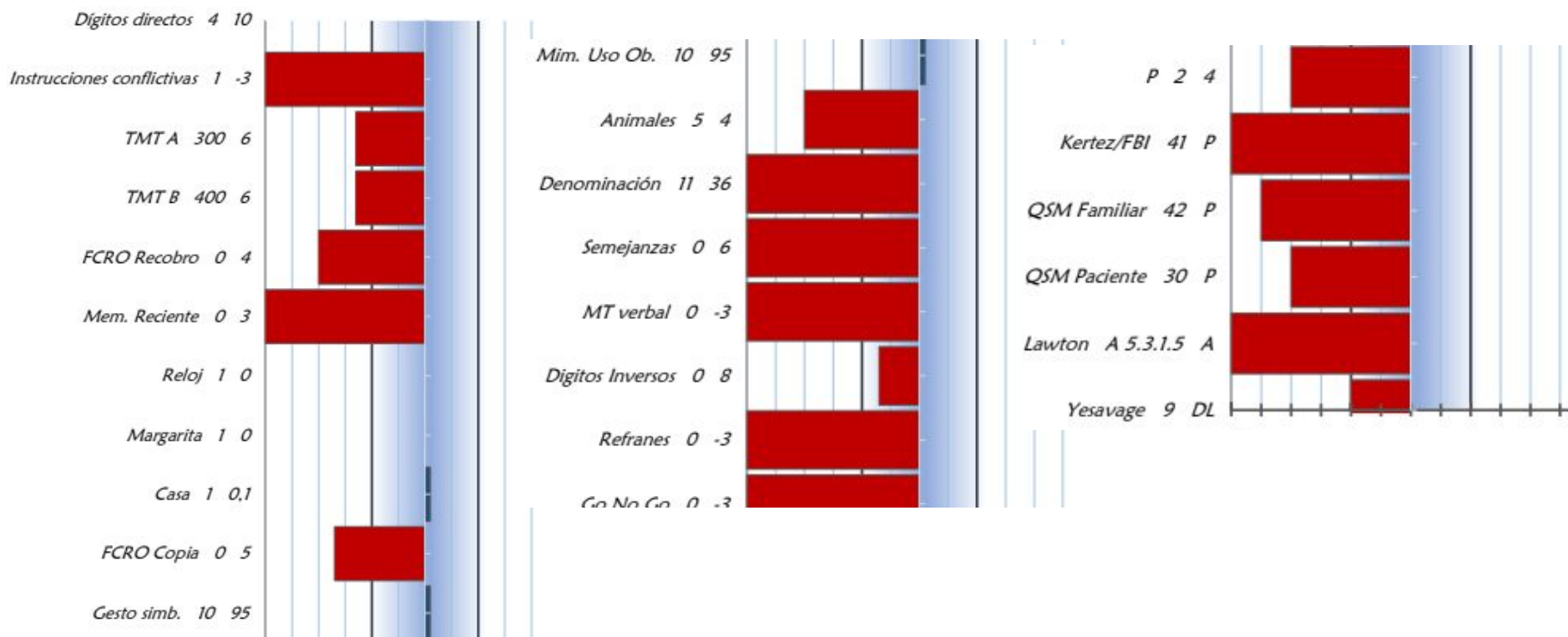
Antecedentes Médicos Y Comportamentales

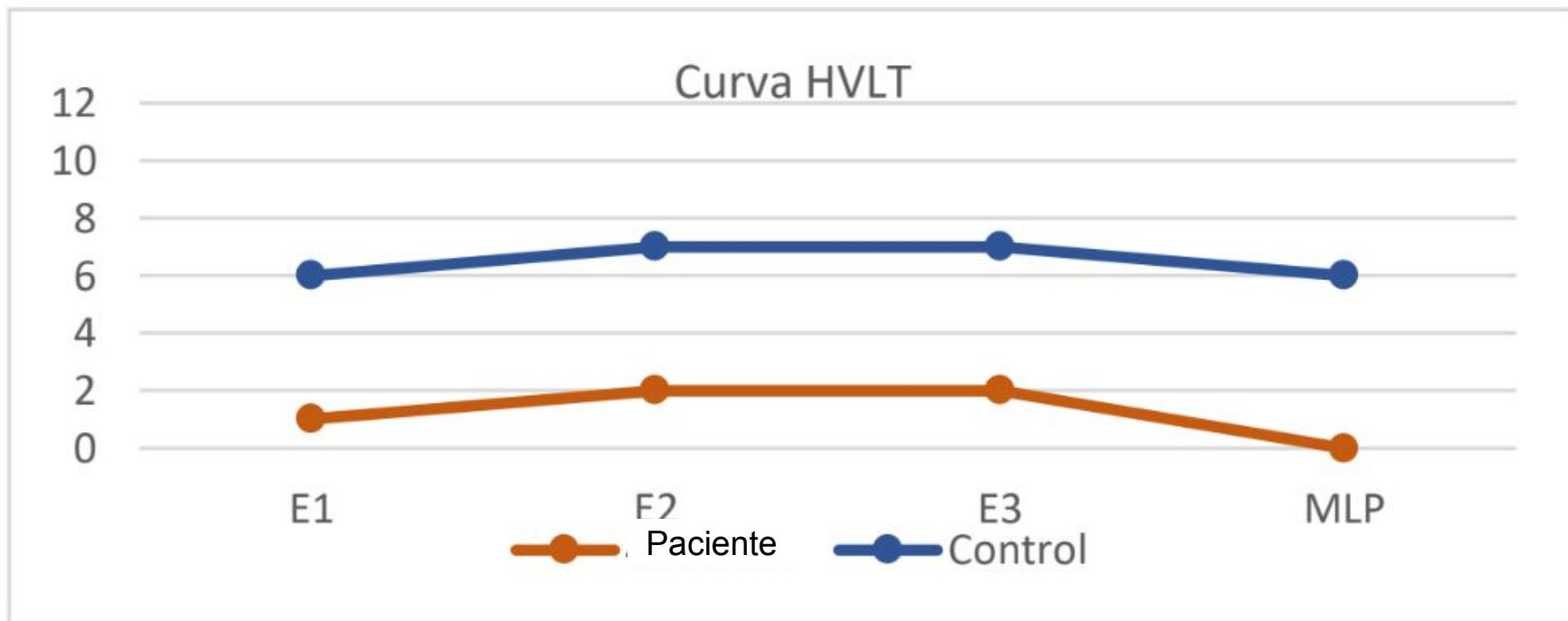
Motivo de consulta

" El tiene alzheimer y parkinson también desde lo que refiere la familiar desde hace más de 10 años" Remite neurología para prueba cognitiva.

Médicos

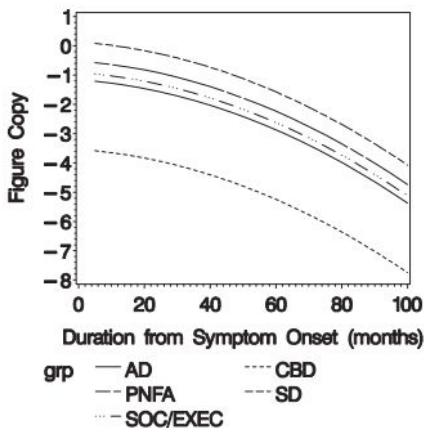
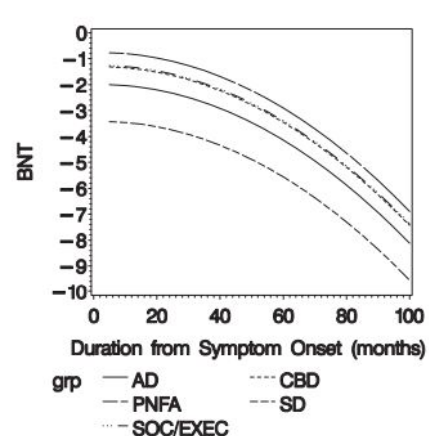
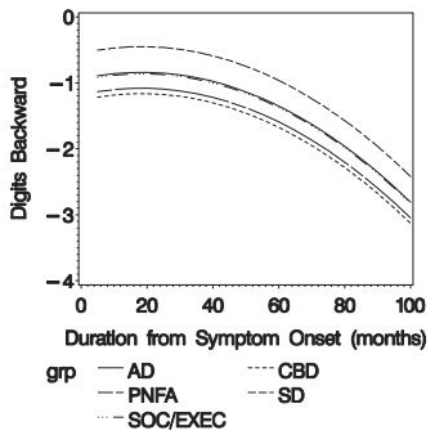
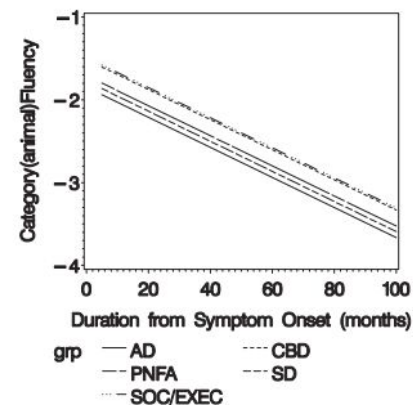
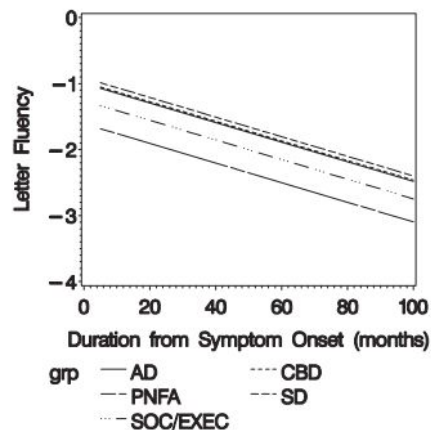
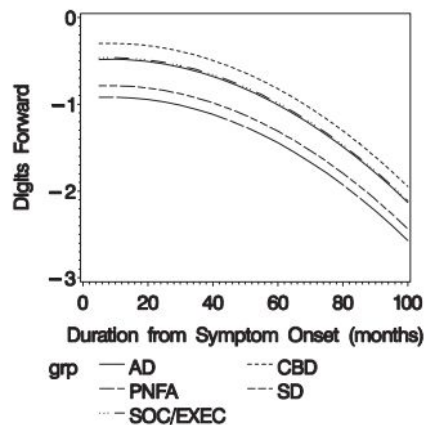
Patológicos /Médicos	Alérgicos
Enfermedad de parkinson desde 1995, insuficiencia renal, apnea del sueño desde hace 8 años, insuficiencia venosa e HTA.	(-)
Sensoriales/Motores	Tóxicos
Dificultad auditiva dejó de usar el audifono. Utiliza gafas para leer.	Exconsumidor de cigarrillo lo dejó hace 50 años y exconsumidor de
Psiquiátricos	Terapéuticos
(-)	Terapias ocupacionales en noviembre del 2021 y físicas hasta el 20 de enero.
Farmacológicos	Quirúrgicos
Utiliza CPAP, carbidopa+levodopa, losartan, metoprolol, paracetamol, atorvastatina, copidrogel, memantina y usa parches de	Cirugía por tumor maligno de riñón, hernias inguinal y varicocele
Traumáticos	Familiares
(-)	Padre con enfermedad de parkinson y dos hermanos.
Paraclínicos	
(-)	





Seguimiento longitudinal DLFT

(Libon, et al. 2009)



DCL DLFT (H70)

Los resultados anteriores muestran un perfil neuropsicológico dentro de lo esperado para su edad y nivel educativo en áreas evaluadas como orientación temporal y espacial, habilidades lingüísticas, memoria semántica, memoria anetógrada verbal, habilidades visoconstruccionales complejas y sencillas, pensamiento asociativo y pensamiento abstracto, **pero con alteraciones principalmente de tipo ejecutivo en la inhibición de respuestas motoras, funcionamiento atencional, velocidad de procesamiento y fluidez verbal.**

Lo cual va de la mano con una adecuada funcionalidad, pero con importantes alteraciones emocionales y comportamentales.

Esta forma, los resultados sugieren un Trastorno neurocognitivo leve disejecutivo, del cual no es clara su etiología, pero que considerando estas alteraciones comportamentales y emocionales de inicio tardío, podrían interrogar la etapa inicial de un trastorno neurocognitivo mayor secundario a una degeneración frontotemporal de variante conductual.

Antecedentes Médicos Y Comportamentales

Motivo de consulta

El paciente refiere que tuvo un evento de ansiedad y depresión, y estuvo hospitalizado dos veces por psiquiatría, pero que se siente mal, que olvida mucho las cosas, olvida donde deja las cosas, olvida fechas importantes. La esposa refiere que quieren descartar qué pasa con el paciente, porque no se ha podido recuperar de los síntomas ansiosos y depresivos, con notable apatía, hay que insistirle para que haga las cosas, hay que pararse de la cama, recuerda muchos eventos de hace muchos. cambios que reportan hace quince meses, que notan de forma

Médicos

Patológicos /Médicos	Alérgicos
Diabetes, Hipertensión arterial.	NA
Sensoriales/Motores	Tóxicos
NA	Bebedor hasta hace dieciocho años.
Psiquiátricos	Terapéuticos
Trastorno depresivo mayor, episodio psicótico.	NA
Farmacológicos	Quirúrgicos
Hidroclorotiazida, Metoprolol, Enalapril, Janumed, Quetiapina.	Lapatomía con ventrorafia, de fractura de brazo derecho.
Traumáticos	Familiares
NA	NA
Paraclínicos	
RM cerebral (23/8/2018): Cambios corticales atróficos supratentoriales y crónica hipertensiva.	

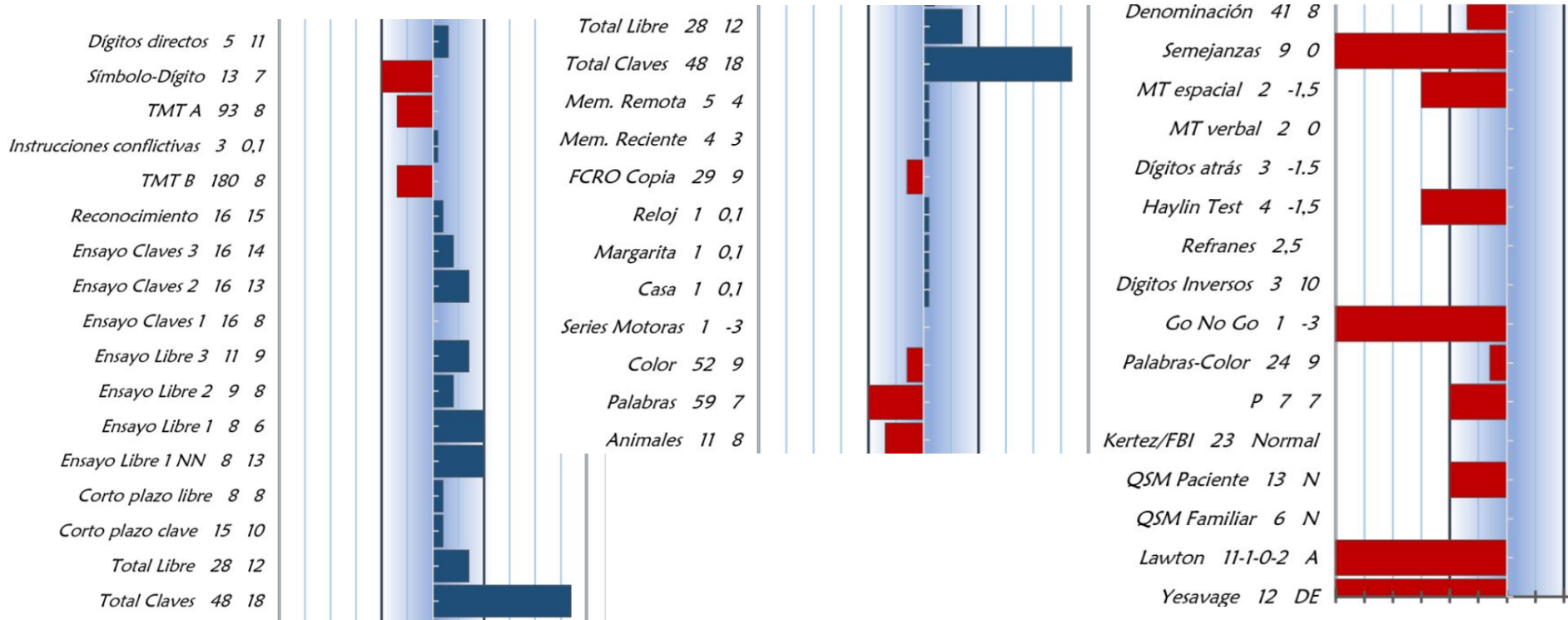
A nivel comportamental y emocional refiere que hace quince meses presenta al parecer intento de suicidio cortándose el cuello y le intenta a hacerle daño a su hijo, lo hospitalizan, con síntomas ansiosos y depresivos, y el segundo episodio de hospitalización fue por síntomas psicóticos, de suspicacia, refiere sentirse ansioso, con ideas no coherentes acerca de sus hijos, "que los recogen en un pantano", pero el paciente hace critica sobre las ideas, ha tenido agresividad verbal y física, le ha llegado a pegar a su esposa, con irritabilidad, ideas de culpa, ideas de minusvalía, preocupaciones por eventos que no están sucediendo.

Patrón de Sueño

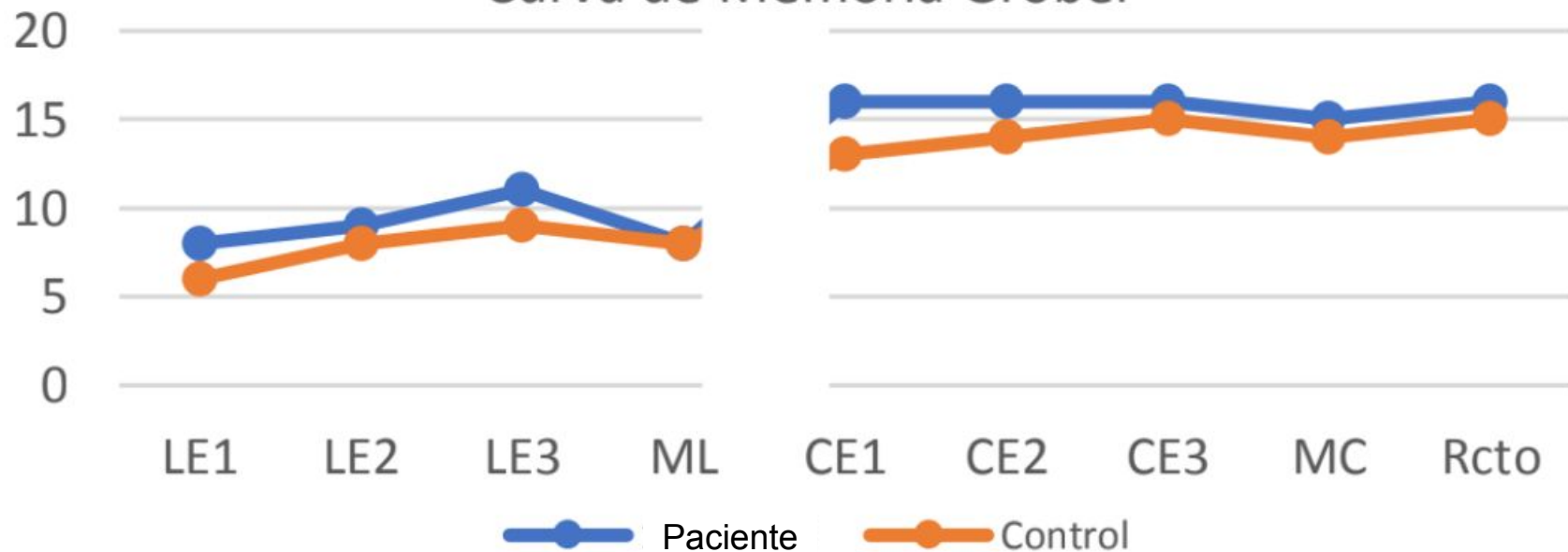
Duerme con medicamento.

Patrón de Alimentación

Normal.



Curva de Memoria Grober



DCM DLFT (H63)

Considerando las características del cuadro, evolución y antecedentes, se identifica un perfil de funcionamiento cognitivo que evidencia un amplio deterioro de las habilidades cognitivas, con implicación general de estas, aumento de la dependencia funcional, las conductas de utilización, dependencia ambiental y de fallas en la autorregulación con progresión marcada en comparación con valoración previa (2019).

Loque de acuerdo con su diagnóstico previo da cuenta de un cuadro compatible **con Demencia frontotemporal posible que en la actualidad se encuentra en un GDS 6**, que requiere acompañamiento permanente y la realización de actividades que promuevan su conexión con el ambiente.

Motivo de consulta

Consultante remitido por neurología para evaluación de su funcionamiento cognitivo, ante sospecha de deterioro DFT vs. deterioro secundario a lesión frontal. Comenzó a tener cambios de conducta desde hace 9 meses, iba a la casa de la mamá de sus hijos y comenzó a insultarlas, decía que le robaban las cosas.

Médicos

Patológicos /Médicos

Normotenso.

Alérgicos

(-)

Sensoriales/Motores

No usa gafas, Tapones de cerumen en los oídos.

Tóxicos

Fumador desde los 20 años, 20 cigarrillos diarios, por 34 años consumo de licor.

Psiquiátricos

¿Tx. de comportamiento?

Terapéuticos

NA

Farmacológicos

Sertralina y Quetiapina. Levotiroxina.

Quirúrgicos

Cadera por fractura. Faquectomía, pterigios. lente intraocular.

Traumáticos

Accidente de tránsito politraumatismo, fractura en cadera izquierda. En una ocasión tuvo un golpe en la cabeza, se estaba peleando con alguien y le hicieron sutura en el parpado. Tuvo caída de un poste y se golpeó la cabeza, aparente lesión en la columna.

Familiares

Madre tuvo demencia.

Paraclínicos

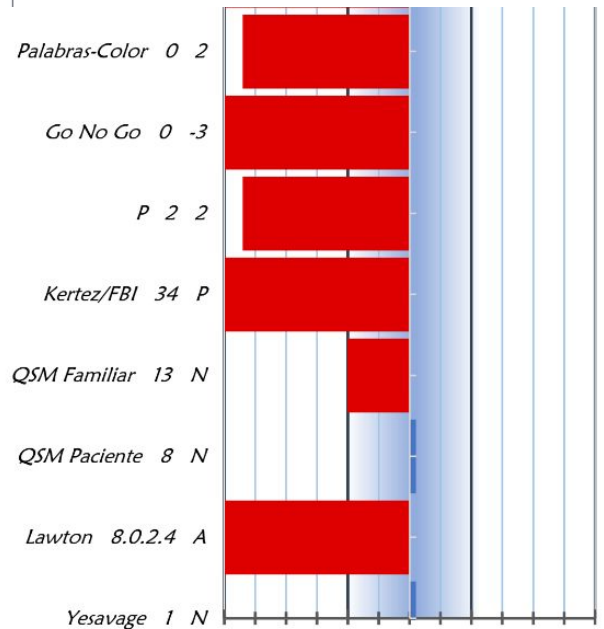
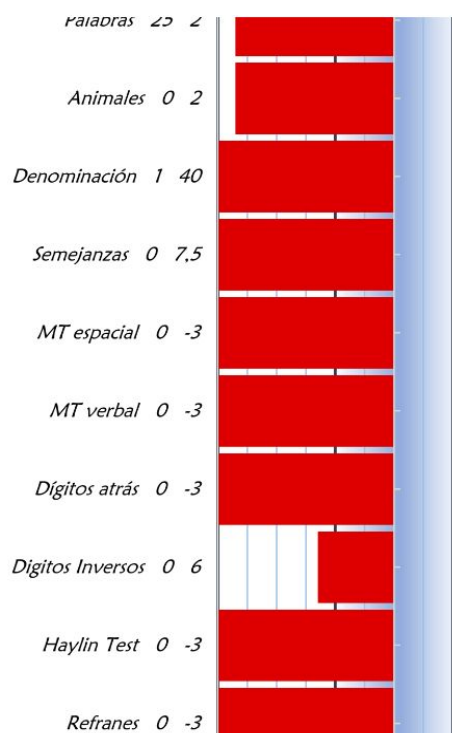
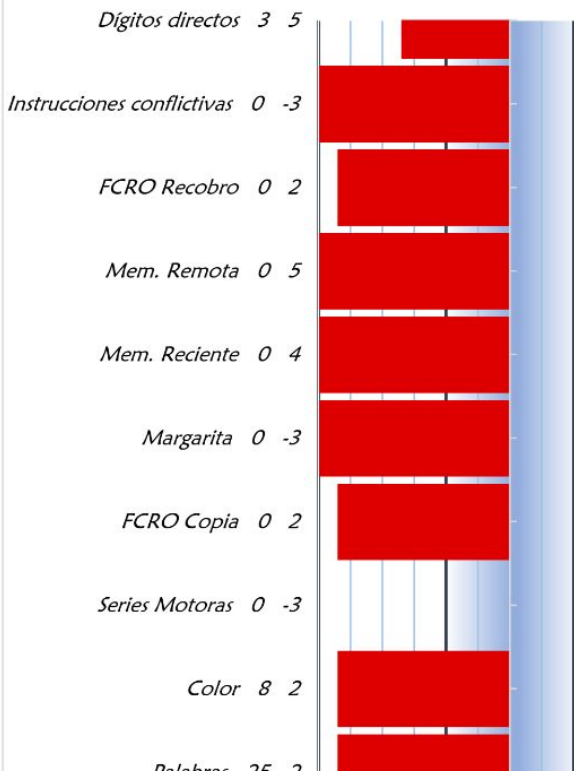
RMN de cerebro simple: Leucoencefalopatía microangiopática periventricular (fazekas 2-3). Cambios involutivos corticales de predominio frontotemporal. Zona de encefalomalacia focal descrita inferior del lóbulo frontal izquierdo. MOCA 13/30

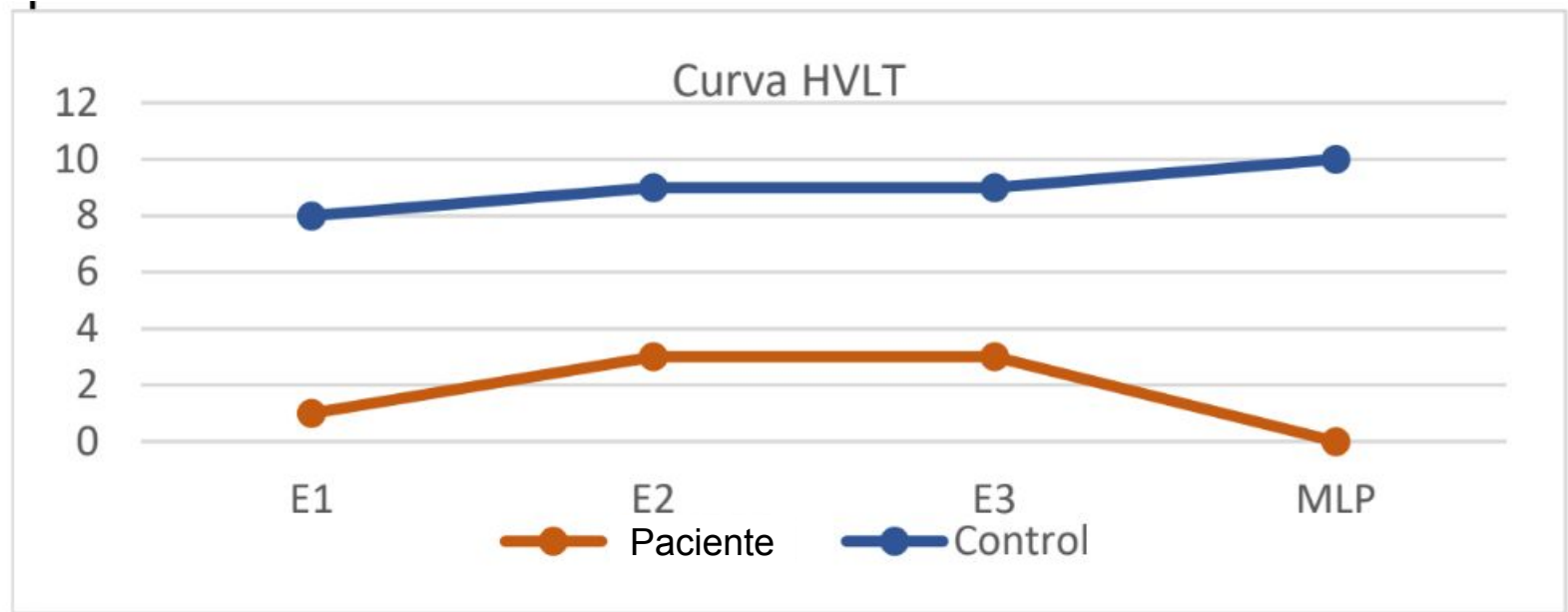
Comportamiento / Ánimo

Acusaba a la mamá de los hijos de que lo robaban. Tenía una caseta en común con ella. Vivía en desaseo, el techo estaba roto, acumulaba cosas, compraba cosas compulsivas. Tenía pornografía, ropa interior de niños. Lo llevaron a la casa familiar, pero hubo muchos conflictos, el señor fue maltratador hacia la familia. A veces no recibía la comida, se fugó en dos ocasiones, se iba a insultar a las personas, se tomó la decisión de que lo llevaran a hogar geirático por el bienestar de la familia. Se inició manejo por neurología, han notado cambios de comportamiento. Coge cosas que no son de él, el señor dice que se las meten. Siempre ha tenido una personalidad "diferente", golpeaba a sus hijos y a su exesposa, estos comportamientos han sido desde que sus hijos eran pequeños, como a los 40 años de edad. A veces hablaba sobre cosas de magia y entidades "una bestia".

Patrón de Sueño

Desde pequeño ha sufrido de insomnio.





Referencias

Campbell, N. L., Unverzagt, F., LaMantia, M. A., Khan, B. A., & Boustani, M. A. (2013). Risk factors for the progression of mild cognitive impairment to dementia. *Clinics in geriatric medicine*, 29(4), 873-893.

Libon, D. J., Xie, S. X., Wang, X., Massimo, L., Moore, P., Vesely, L., ... & Grossman, M. (2009). Neuropsychological decline in frontotemporal lobar degeneration: a longitudinal analysis. *Neuropsychology*, 23(3), 337.

Hildebrandt, H., Fink, F., Kastrup, A., Haupts, M., & Eling, P. (2013). Cognitive profiles of patients with mild cognitive impairment or dementia in Alzheimer's or Parkinson's disease. *Dementia and geriatric cognitive disorders extra*, 3(1), 102-112.

Mitchell, A. J., & Shiri-Feshki, M. (2009). Rate of progression of mild cognitive impairment to dementia—meta-analysis of 41 robust inception cohort studies. *Acta psychiatrica scandinavica*, 119(4), 252-265.

Farias, S. T., Mungas, D., Reed, B. R., Harvey, D., & DeCarli, C. (2009). Progression of mild cognitive impairment to dementia in clinic-vs community-based cohorts. *Archives of neurology*, 66(9), 1151-1157.

Biundo, R., Weis, L., Facchini, S., Formento-Dojot, P., Vallelunga, A., Pilleri, M., & Antonini, A. (2014). Cognitive profiling of Parkinson disease patients with mild cognitive impairment and dementia. *Parkinsonism & related disorders*, 20(4), 394-399.

Serrano, C. M., Dillon, C., Leis, A. M., Taragano, F. E., & Allegri, R. F. (2013). Deterioro cognitivo leve: riesgo de demencia según subtipos.

Garrett, K. D., Browndyke, J. N., Whelihan, W., Paul, R. H., DiCarlo, M., Moser, D. J., ... & Ott, B. R. (2004). The neuropsychological profile of vascular cognitive impairment—no dementia: comparisons to patients at risk for cerebrovascular disease and vascular dementia. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 19(6), 745-757.

Referencias

Miranda, A., Pruvost, M., Palau, F. G., Rimoldi, M. F., Viale, M., & Cáceres, M. (2015). Perfiles neuropsicológicos:: Enfermedad de Alzheimer y Parkinson, Deterioro cognitivo leve, Trastorno depresivo mayor y Envejecimiento. *Cuadernos de Neuropsicología*, 9(2), 30-48.

Velásquez-Pérez, L., Guerrero-Camacho, J., Rodríguez-Agudelo, Y., Alonso-Vilatela, M. E., & Yescas-Gómez, P. (2008). Conversión de deterioro cognitivo leve a demencia. *Rev Ecuat Neurol*, 17(1-3), 25-32.

Caccappolo-Van Vliet, E., Manly, J., Tang, M. X., Marder, K., Bell, K., & Stern, Y. (2003). The neuropsychological profiles of mild Alzheimer's disease and questionable dementia as compared to age-related cognitive decline. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 9(5), 720-732.

Alexopoulos, P., Grimmer, T., Perneczky, R., Domes, G., & Kurz, A. (2006). Progression to dementia in clinical subtypes of mild cognitive impairment. *Dementia and geriatric cognitive disorders*, 22(1), 27-34.

Perez-Blanco, L., Felpete, A., Patten, S. B., Mallo, S. C., Pereiro, A. X., Campos-Magdaleno, M., & Juncos-Rabadan, O. (2022). Do informant-reported subjective cognitive complaints predict progression to mild cognitive impairment and dementia better than self-reported complaints in old adults? A meta-analytical study. *Ageing Research Reviews*, 101772.

GRACIAS

